

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085531-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE
RECORRENTE: CRISTINA DA SILVA CALDEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DO RETO E NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO DO UTERO. LAUDO MÉDICO ATESTA A EXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para determinar que os réus providenciem e comprove nos autos a efetivação do atendimento médico da parte autora na especialidade de Oncologia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R\$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das penalidades administrativas, cíveis e penais aos responsáveis. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Comunique-se ao Juizado Especial de origem acerca do teor da presente decisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5085531-57.2024.4.02.5101

510015027300 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085531-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE
RECORRENTE: CRISTINA DA SILVA CALDEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela parte Autora em face da decisão dos autos originários, que indeferiu a tutela para que fosse realizada 1º atendimento em oncologia, em razão do respeito à fila de atendimento do SUS.

A parte autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de reto (CID 10 C20), conforme exame de colonoscopia com resultado em 24/07/2024, sendo encaminhada para CONSULTA EM ONCOLOGIA - Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia) em 08/08/2024 e inserida no Sistema Estadual de Regulação - SER. Segundo laudo médico, a parte autora necessita com URGÊNCIA de atendimento oncológico, e se encontra impossibilitada de aguardar em fila de espera (Rank: 164), havendo risco de sofrer danos irreparáveis e irreversíveis à sua saúde. Apresentado o caso à Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), foi exarado Parecer Técnico nº SES/SJ/CRLS nº 1854/2024, em 29/10/2024, dando conta de que a parte autora encontra-se EM FILA e, no momento, não há vaga disponível para a regulação da demanda pleiteada.

Decisão desta relatora concedendo a tutela, evento 9.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Decido.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, “sic”:

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.” (grifo nosso)”

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(…)

Destarte, fica evidente que as responsabilidades quanto à execução das ações finalísticas de prestação de serviços de saúde dividem-se entre a União, os Estados e os Municípios.

Adentrando ao caso concreto, verifico que, conforme parecer do NATJUS, “*Em consulta ao banco de dados do Ministério da Saúde³ foram encontradas as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Câncer de Cólon e Reto, nas quais consta que “... Doentes com diagnóstico de câncer colorretal devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento”*

Analisando as provas contidas nos autos principais, verifico que, de fato, está comprovado que a parte autora atravessa sérios problemas de saúde e necessita de avaliação oncológica com urgência para definição do tratamento.

Nessa toada, a Lei 13.896/2019 promoveu alteração na Lei 12.732/2012, dispondo que exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna devem ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias, o que só reforça o reconhecimento da necessidade de rápido diagnóstico para imediato tratamento, previsto no art. 2º da Lei 12.732/2012, *in verbis*:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”(NR).

O Parecer do NATJUS, evento 7, do dia 29 de outubro de 2024, confirma o diagnóstico e informa que a parte autora entrou na fila no dia 08 de agosto de 2024 para ambulatorio 1ª vez – coloproctologia (oncologia) com classificação de risco amarelo sob a responsabilidade da central REUNI-RJ.

Assim, visto que a autora está em fila desde 08/08/2024 tendo transcorrido prazo legal de 30 dias, entendo que não mais pode subsistir a demora injustificada da parte ré, visto que o laudo médico no evento 1, Anexo2, pg. 22 dos autos originários constata existência de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, hiperlipidemia, hemorroidas, melena, neoplasia maligna do reto e neoplasia de comportamento incerto do utero, devendo ser feito os exames para melhor diagnóstico e tratamento da doença, informando o profissional da saúde risco de progressão da doença.

Desta forma, conceder à parte autora a antecipação dos efeitos da tutela, nesta oportunidade, para atendimento e tratamento de seu quadro de saúde, não significaria "furar a fila" e passar à frente de outras pessoas que, visto que está de acordo com a legislação pátria.

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC e entendo que os argumentos e provas nos autos são suficientes a gerar o deferimento do presente pedido liminar.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso da parte autora, **para determinar que os réus providenciem e comprove nos autos a efetivação do atendimento médico da parte autora na especialidade de Oncologia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária**, no valor de R\$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das penalidades administrativas, cíveis e penais aos responsáveis. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Comunique-se ao Juizado Especial de origem acerca do teor da presente decisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se.